

## Evaluation : les infections sexuellement transmissibles

### Cas clinique

Mr N. G. âgé de 29 ans consulte pour Brulures mictionnelles apparu 48 H après sortie en boîte de nuit. A l'examen:

- Temp = 37.8°C
- Examen des OGE : écoulement urétral (photo ci jointe)

Quel est votre Dg ?

Citer les 2 principaux germes responsables d'urétrite en Tunisie :

Quel complément d'interrogatoire ?

IST et MST : différence ?

Les virus responsables d'infections sexuellement transmissibles sont :

- A. Virus Cocksackie A
- B. Virus de l'hépatite B
- C. Virus de l'hépatite C
- D. *Human papilloma virus*
- E. *Cytomégalo virus*

Les gonocoques :

- A. sont des diplocoques à Gram négatif
- B. peuvent sécréter une  $\beta$  lactamase
- C. sont des bactéries exclusives de l'espèce humaine
- D. résistent dans le milieu extérieur
- E. peuvent occasionner des arthrites aiguës

Chez l'homme, l'urétrite à gonocoque :

- A. a une incubation courte de 4 à 6 jours
- B. peut s'accompagner d'une balanite
- C. est caractérisée par un écoulement clair peu abondant
- D. s'accompagne de brûlure mictionnelle intense
- E. s'accompagne de fièvre

**Les complications d'une vulvo-vaginite gonococcique chez la femme sont :**

- A. Endométrite
- B. Salpingite
- C. Pelvipéritonite
- D. Syndrome de Curtis
- E. Cervicite

**Parmi les complications de l'infection à gonocoque :**

- A. La stérilité
- B. Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
- C. La salpingite
- D. La conjonctivite
- E. L'oligo-arthrite

**Chez l'homme, l'urétrite à *Chlamydia trachomatis* :**

- A. a une incubation de 10 à 15 jours
- B. est caractérisée par un écoulement purulent jaunâtre
- C. peut rester asymptomatique
- D. s'accompagne de fièvre
- E. peut se compliquer d'une orchite-épididymite

**Les localisations extra-génitales du gonocoque sont :**

- A. Ano-rectites
- B. Pharyngite
- C. Rétinite
- D. Bactériémie
- E. Arthrite

**Indiquez la (les) forme(s) parasitaire(s) de *Trichomonas vaginalis* responsable(s) de la contamination interhumaine :**

- A. Kyste
- B. Oocyste
- C. Gamétocyte
- D. Forme végétative
- E. Larve

**Les pertes vaginales au cours d'une vulvo-vaginite à *T. vaginalis* sont :**

- A. verdâtres
- B. peu abondantes
- C. malodorantes
- D. accompagnées de dyspareunie
- E. accompagnées de prurit

**Parmi les agents infectieux suivants, lesquels peuvent être responsables d'urétrite :**

- A. *Chlamydia trachomatis*
- B. *Neisseria gonorrhoeae*
- C. *Ureaplasma urealyticum*
- D. *Trichomonas vaginalis*
- E. *Candida albicans*

**Citer 3 manifestations extra-génitales de l'infection à *Chlamydia trachomatis* ?**

**Citer 2 molécules actives sur le gonocoque :**

**Citer 2 molécules actives sur *Chlamydia trachomatis* :**

**Les antibiotiques indiqués dans les urétrites à *Chlamydia trachomatis* sont :**

- A. Azithromycine (Zithromax®)
- B. Doxycycline (Vibramycine®)
- C. Ofloxacin (Oflocet®)
- D. Amoxicilline (Saifoxyl®)
- E. Métronidazole (Flagyl®)

**Le traitement d'une urétrite à gonocoque nécessite :**

- A. une dose unique d'un antibiotique actif
- B. une durée de traitement de 10 jours
- C. l'association d'un antibiotique actif sur *Chlamydia trachomatis*
- D. l'association de 2 antibiotiques actifs sur gonocoque
- E. une durée de 3 jours si elle est associée à une atteinte extra génitale

**Quels sont les étiologies d'un écoulement persistant malgré un traitement bien conduit ?**

**Comment contrôler un patient qui a une urétrite traitée ?**

**Les complications à craindre suite à une urétrite à gonocoque incorrectement traitée, sont:**

- A. La prostatite
- B. L'orché-épididymite
- C. La salpingite chez la partenaire
- D. Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
- E. Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis

**Une urétrite aiguë à gonocoque peut se compliquer de :**

- A. Arthrite aiguë
- B. Glomérulonéphrite
- C. Epididymite
- D. Ostéite
- E. Stérilité

**Les agents infectieux responsables d'une cervico-vulvovaginite sexuellement transmise sont :**

- A. *Chlamydia trachomatis*
- B. *Neisseria gonorrhoeae*
- C. *Mycoplasma genitalum*
- D. *Candida albicans*
- E. *Trichomonas vaginalis*

**Quel est le traitement d'une vulvo-vaginite à *T. vaginalis* chez une femme enceinte ?**

**La prise en charge d'une urétrite comporte :**

- A. Une hospitalisation systématique
- B. Une antibiothérapie visant la syphilis et le gonocoque
- C. Le traitement systématique du partenaire
- D. Le dépistage systématique d'une infection VIH
- E. Le dépistage systématique d'une infection par le virus VHC

**Quel est le traitement le plus adapté à la vaginose bactérienne (*Gardnerella vaginalis*) ?**

- A. Fluconazole
- B. Kétoconazole
- C. Streptomycine
- D. Métronidazole
- E. Thiophénicol

**En faveur d'une infection à *Gardnerella vaginalis* :**

- A. PH < 4,5
- B. Leucorrhées évocatrices
- C. Test olfactif : odeur caractéristiques de poisson dégagée par les sécrétions vaginales
- D. Présence de clue cells à l'examen direct
- E. Douleur pelvienne (dyspareunie)

**Cas Clinique : Suite...**

**Notre malade est perdu de vue.**

**Reconsulte après 6 mois pour une ulcération génitale (photo ci jointe)**

**+ Adénopathie inguinale indolore ferme.**

**Quel est votre diagnostic ?**

- A. Maladie de Nicolas et Favre
- B. Herpès génital
- C. Chancre syphilitique
- D. Chancre mou
- E. Donovanose

**Le chancre d'inoculation de la syphilis :**

- A. Apparaît 21 jours après le contact sexuel contaminant
- B. Est indolore
- C. Fourmille de tréponèmes
- D. Est contemporain d'autres lésions cutanéomuqueuses syphilitiques
- E. Repose sur une base indurée

**Le chancre de la syphilis primaire se caractérise par :**

- A. une induration
- B. un prurit
- C. une tendance spontanée à la guérison
- D. Le plus souvent unique
- E. la présence d'une adénopathie satellite

**Les primo-infections syphilitiques sans chancre sont dues à :**

- A. Syphilis prénatale
- B. Syphilis transfusionnelle
- C. Syphilis décapitée
- D. Syphilis chez un patient VIH
- E. Syphilis chez une femme enceinte

**Citer les 3 phases évolutives de la syphilis :**

**Parmi les infections sexuellement transmissibles suivantes lesquelles peuvent être responsables d'ulcérations génitales :**

- A. Syphilis
- B. Chancre mou
- C. Lymphogranulomatose vénérienne
- D. Infection à Herpes simplex
- E. Infection à *Mycoplasma genitalium*

**Une ulcération génitale chez la femme peut faire évoquer le diagnostic d'une infection à**

- A. *Treponema pallidum*
- B. *Haemophilus ducreyi*
- C. *Ureaplasma urealyticum*
- D. *Chlamydia trachomatis*
- E. *Herpes simplex virus 2*

**Il n'a pas reçu le traitement reconsulte avec éruption généralisée (photo ci jointE)**

**Quel est votre diagnostic ?**

**Les manifestations cliniques suivants peuvent être observées dans la syphilis secondaire:**

- A. Chancre d'inoculation
- B. Adénopathies inguinale satellite
- C. Gommages syphilitiques
- D. Plaques muqueuses
- E. Syphilides papuleuses

**Les localisations viscérales notées au cours d'une syphilis tertiaire sont :**

- A. Des gommages
- B. Une aortite
- C. Une méningite
- D. Un signe d'Argyll Robertson
- E. Une hépatite sclérogommeuses

**La première réaction sérologique à se positiver au cours de la syphilis :**

- A. La réaction de Nelson
- B. La réaction du TPHA
- C. La réaction de l'immunofluorescence indirecte (FTA)
- D. La réaction de Widal
- E. La réaction de VDRL

**Quel test sérologique de la syphilis reste positif même après un traitement efficace :**

**Interpréter la sérologie syphilitique suivante :**

- **TPHA : 1/320 et VDRL à 4 :**
- **TPHA : 1/2560 et VDRL >16:**
- **TPHA – (<160) et VDRL – (0):**
- **TPHA : négatif et VDRL : positif:**

**Une sérologie syphilitique retrouvant un TPHA négatif et un VDRL positif:**

- A. **peut se rencontrer lors d'une infection virale**
- B. **est le profil d'une cicatrice sérologique**
- C. **Peut être un faux positif**
- D. **permet d'éliminer une syphilis ancienne traitée ou non**
- E. **peut être observée en présence d'anticorps anti-phospholipides**

**Étiologies d'une réaction sérologique syphilitique faussement positive ?**

**Quel est le traitement médicamenteux d'une syphilis primaire ?**

**Les antibiotiques actifs sur Treponema pallidum sont :**

- A. **Doxycycline**
- B. **Ofloxacin**
- C. **Azithromycine**
- D. **Benzathine pénicilline**
- E. **Spectinomycine**

**Quel est le traitement du Syphilis neurologique ?**

Un patient allergique à la pénicilline ayant une sérologie syphilitique positive, Quels sont les familles d'antibiotiques que vous pouvez prescrire ?

Un patient ayant une syphilis primaire, 3 heures après le début du traitement par pénicilline, le malade a présenté de la fièvre, une éruption et des poly-adénopathies, Quel est votre diagnostic ?

Sur quels arguments vous jugez l'efficacité du traitement de la syphilis ?

Le(s) germe(s) responsable(s) de Donovanose:

- A. *Treponema pallidum*
- B. *Klebsiella granulomatis*
- C. *Calymmatobacterium granulomatis*
- D. *Haemophilus ducreyi*
- E. *Chlamydia trachomatis*

Cas clinique : suite ...

Il a reçu son traitement. Il amène sa partenaire qui a un prurit et des douleurs périnéales ++ (photo ci-joint)

Quel est votre diagnostic ?

Le germe responsable du chancre mou est :

- A. *Treponema pallidum*
- B. *Herpès*
- C. *Gonocoque*
- D. *Haemophilus ducreyi*
- E. *Chlamydia trachomatis*

Le germe responsable du lymphogranulomatose vénérienne est :

- A. *Treponema pallidum*
- B. *Herpès*
- C. *Gonocoque*
- D. *Haemophilus ducreyi*
- E. *Chlamydia trachomatis*

Parmi les IST suivantes lesquelles peuvent être responsables d'ulcérations génitales

- A. syphilis
- B. chancre mou
- C. lymphogranulomatose vénérienne
- D. infection à *herpes simplex*
- E. infection à *Mycoplasma genitalum*

Une ulcération génitale chez la femme peut faire évoquer le diagnostic d'une infection à

- A. *Treponema pallidum*
- B. *Haemophilus ducreyi*
- C. *Ureaplasma urealyticum*
- D. *Chlamydia trachomatis*
- E. *Herpes virus 2*

Cas clinique : suite ...

2 ans plus tard, il a développé des lésions bourgeonnante du pénis (photo ci joint)

Quel est votre diagnostic ?

Parmi les infections suivantes, la(es) quelle(s) peu(ven)t être transmise(s) par voie sexuelle :

- A. Herpès génital
- B. Varicelle
- C. Candyrome acuminé
- D. Hépatite virale E
- E. Zona généralisé

Cas clinique : Suite...

2 ans plus tard, apparition d'une éruption maculo-papuleuse qui prédomine sur le tronc (photo ci jointe)

Biologie: thrombopénie + ASAT et ALAT ↑

Quel est votre diagnostic ?

- A. Roséole syphilitique
- B. Rougeole
- C. Primo-infection VIH
- D. Rubéole
- E. MNI

**Parmi les signes suivants, quels sont ceux que vous ne retrouvez pas lors de la primo-infection VIH:**

- A. La leucoplasie chevelue de la langue
- B. Le sarcome de Kaposi
- C. La diarrhée chronique
- D. Les ulcérations génitales
- E. La méningite lymphocytaire

**Le virus de l'immunodéficience humaine :**

- A. est lymphotrope.
- B. est neurotrope
- C. a une activité transcriptase inverse
- D. a un noyau central d'ADN
- E. est un adénovirus

**Citer 3 cellules cibles du VIH :**

**Les cellules cibles du VIH sont :**

- A. Les lymphocytes T CD4+
- B. Les monocytes/macrophages
- C. Les cellules microgliales du cerveau
- D. Les cellules dendritiques du cerveau
- E. Les cellules folliculaires des ganglions

**Citer les 3 principaux modes de contamination par le VIH :**

**Comment se transmet le VIH ?**

- A. Rapports sexuels
- B. Materno-fœtale
- C. Baiser
- D. Pique d'insecte
- E. Transfusion

**Les facteurs de risque de la transmission sexuelle du VIH sont:**

- A. Une charge virale plasmatique élevée du partenaire
- B. La phase de primo-infection
- C. Des CD4 supérieurs à 200/mm<sup>3</sup>
- D. La présence d'ulcères génitaux
- E. Le saignement au cours du rapport sexuel

**Citer 4 facteurs augmentant les risques de transmission sexuelle du VIH :**

**Concernant la transmission du VIH de la mère à l'enfant :**

- A. Elle ne survient qu'au moment de l'accouchement
- B. L'allaitement maternel n'a pas de risque
- C. La charge virale plasmatique maternelle constitue un facteur de risque
- D. La prise des antirétroviraux par la mère permet de réduire le risque
- E. La prise des antirétroviraux par l'enfant permet de réduire le risque

**Quel est le nombre de cas de sujets Infectés par le VIH en Tunisie en 2016**

- A. 1 357
- B. 2 357
- C. 3 357
- D. 6 000
- E. 8000

**Comment faire de diagnostic de l'infection par le VIH chez notre patient ?**

- A. ARN VIH
- B. Sérologie VIH
- C. Test rapide VIH
- D. Western Blot VIH
- E. Ag P24

**Citer 2 tests sérologiques permettant la confirmation d'une infection VIH :**

**Dans quel cas le dépistage du VIH est obligatoire et légal ?**

**Les critères suivants permettent de classer un patient infecté par le VIH au stade A :**

- A. Primo-infection symptomatique
- B. Absence de symptômes
- C. Pneumopathie récidivante
- D. Tuberculose pulmonaire
- E. Lymphadénopathie généralisée persistante

**Les candidoses qui définissent le stade SIDA sont :**

- A. Candidose oropharyngée
- B. Candidose pharyngée persistante
- C. Candidose bronchique
- D. Candidose de l'œsophage
- E. Candidose intestinale

**Les infections virales qui définissent le SIDA sont :**

- A. Zona récurrent
- B. Mononucléose infectieuse
- C. Rétinite à *Cytomégalovirus* (CMV)
- D. Colite à CMV
- E. Herpes génital récurrent

**Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :**

- A. une pneumocystose
- B. une tuberculose cavitaire pulmonaire
- C. un muguet buccal
- D. un zona multi métamérique
- E. une langue chevelue

**Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :**

- A. Une pneumocystose
- B. Une tuberculose pulmonaire
- C. Une candidose vaginale persistante
- D. Un zona multimétamérique
- E. Une leucoplasie chevelue de la langue

**Citer 3 pathologies appartenant au groupe C :**

**Quels sont les cancers les plus fréquemment associés au VIH ?**

**Citer 3 infections opportunistes dont le risque de survenue est important si la taux de CD4 est < 100/mm<sup>3</sup> chez les patients infectés par le VIH :**

**Cas clinique : Suite...**

**Examen clinique : Candidose buccale (photo ci-joint)**

**Un bilan a été fait:**

- Charge virale: 120 000 copies/ml
- CD4 = 40 E/mm<sup>3</sup>
- ASAT, ALAT, Créat, NFS : normaux
- Sérologie toxoplasmose : IgG +
- Ag HBs (-), Ac Anti-HVC (-)

**Rx thorx : normal**

**Pourquoi faire le dépistage de la primo-infection ?**

**Citer 5 indications du traitement ARV :**

**Citer les principes généraux du traitement d'une infection VIH :**

**Si ce Monsieur consulte pour une fièvre à 38,5°C associée à une toux sèche et à un essoufflement depuis quelques jours.**

**Quel diagnostic suspectez-vous de première intention ?**

**Un patient infecté par le VIH présente une dyspnée fébrile évoluant depuis quelques jours. L'examen note une maigreur, une cyanose et des râles crépitants diffus.**

**Quels sont les diagnostics à évoquer ?**

**Quel examen sera le plus contributif pour affirmer le diagnostic que vous suspecter ?**

**Quels autres examens demandez-vous ?**

**Quel traitement prescrivez-vous initialement ?**

**Après la guérison de l'épisode actuel, quel traitement prescrivez-vous?**

**Devant un syndrome déficitaire chez un patient infecté par le VIH, quels sont les diagnostics à Évoquer ?**

**Les arguments épidémio-cliniques en faveur de la toxoplasmose cérébrale sont :**

- A. L'ancienneté de l'infection par le VIH
- B. Taux de CD4 à 40
- C. L'absence de prophylaxie primaire anti-toxoplasmose
- D. Signes neurologiques de localisation
- E. L'absence d'antécédent d'infections opportunistes

**Quel est l'examen para-clinique de confirmation de la Toxoplasmose cérébrale :**

- A. Une sérologie toxoplasmique
- B. Recherche de toxoplasmes par PCR dans le LCR
- C. Scanner cérébral
- D. Biopsie cérébrale stéréotaxique avec anapath
- E. Cytochimie du liquide céphalorachidien

**Les arguments qui permettent de retenir ce diagnostic sont :**

- A. Présence d'abcès multiples en cocarde au scanner cérébral
- B. Sérologie toxoplasmique positive
- C. Présence d'œdème papillaire au fond d'œil
- D. Réponse favorable au traitement spécifique
- E. Albuminorrachie supérieure à 1 g/L

**Quel est la durée du traitement de la rétinite à CMV ?**

**Au cours de l'infection à VIH :**

- A. Le traitement ARV est indiqué si le taux de CD4 est  $< 500/\text{mm}^3$
- B. La pneumocystose pulmonaire fait partie des infections opportunistes les plus fréquentes
- C. La cryptococcose neuro-méningée est l'infection opportuniste la plus fréquente du SNC
- D. Une antibioprophylaxie par cotrimoxazole est indiquée si le taux de CD4 est  $< 200/\text{mm}^3$
- E. La charge virale VIH est un marqueur d'évolutivité de la maladie

**Citer 3 mesures de prévention de l'infection VIH :**

**Citer 3 mesures de prévention de la transmission materno-fœtale de l'infection VIH :**

**Individuellement, quel est le moyen de prévention du VIH le plus efficace?**

- A. La circoncision**
- B. Le préservatif**
- C. Le traitement antirétroviral du partenaire séropositif (TasP)**
- D. Le traitement antirétroviral du partenaire séronégatif (PrEP)**
- E. Un programme de conseil d'abstinence**